GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE SANIDAD

REGISTRO DE ACTIVIDAD DE ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA (RAE-CMBD)

SOLICITUD DE EXTRACCIÓN DE DATOS – COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento consta de dos partes:

A. Solicitud de extracción

B. Compromiso de confidencialidad.

El documento completo deberá ser firmado y remitido al Área de Información y Estadísticas Asistenciales de la Subdirección General de Información Sanitaria por cualquiera de los medios siguientes:

- Por correo electrónico: **icmbd@sanidad.gob.es**
- Por correo postal: Subdirección General de Información Sanitaria, Área de Información y Estadísticas Asistenciales, Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18-20; 28014 Madrid. España

Tras la recepción de la solicitud se remitirá un correo electrónico de confirmación informando de los plazos previsibles para su resolución. En el caso de que la información sea insuficiente para resolverla, se solicitará al peticionario que la complete, quedando el procedimiento interrumpido hasta que las deficiencias sean subsanadas.

En la solicitud se deberá consignar el periodo solicitado, las variables y los criterios de selección de los registros.

En ningún caso se podrán efectuar cesiones que supongan la exportación de la totalidad de la base de datos ni exportaciones parciales que permitan la generación de la misma mediante agregación. Tampoco se podrán extraer datos que permitan la identificación de personas físicas o unidades informantes.

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal - y desde mayo de 2018 del Reglamento Europeo de Protección de Datos-, le comunicamos que sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero automatizado "registro de solicitudes de información", con fines exclusivamente de seguimiento, gestión y divulgación de las actividades, productos y servicios del Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud. En cualquier caso, podrá ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos, en los términos descritos en la ciada Ley, a través de los mismos circuitos establecidos para las solicitudes.

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE SANIDAD

A.1. **1) IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO**

Apellidos, Nombre	Elena Izquierdo, José María		NIF: 07959043P
Institución/Organización	Universidad de Salamanca		
Lugar de trabajo	Departamento de Economía Aplicada - Facultad de Derecho		
Cargo que ocupa	Profesor Titular EU, Dto. de Economía Aplicada		
Dirección profesional de contacto	Facultad de Derecho - Campus Miguel de Unamuno s/n	CP: 37007	Localidad: Salamanca
Teléfono de contacto	9232945500 Ext.1653	Otro teléfono: 652800329	
Correo electrónico de contacto	jomarel@usal.es		

A.1. **2) IDENTIFICACIÓN DE COLABORADORES**

Apellidos, Nombre			NIF:
Institución/Organización			
Lugar de trabajo			
Cargo que ocupa			
Dirección profesional de contacto		CP:	Localidad:
Teléfono de contacto		Otro teléfono:	
Correo electrónico de contacto			

Apellidos, Nombre			NIF:
Institución/Organización			
Lugar de trabajo			
Cargo que ocupa			
Dirección profesional de contacto		CP:	Localidad:
Teléfono de contacto		Otro teléfono:	
Correo electrónico de contacto			

A. 2) DATOS CMBD y RAE-CMBD SOLICITADOS – FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA SOLICITUD

Se especificarán los datos del RAE_CMBD solicitados (periodo, variables, criterios de búsqueda).

De manera resumida se indicará la finalidad, objetivos, elaboración y análisis a los que serán sometidos y cómo y cuándo se divulgarán los resultados obtenidos.

A.2.1. Datos CMBD/RAE-CMBD Solicitados.

Como anexo a este formulario se encuentra la relación de variables disponibles en ambas bases de datos.

Consignar el periodo y variables solicitadas.

NOTAS IMPORTANTES:

1.- Deberán especificarse los criterios clínicos de extracción de diagnósticos y/o procedimientos de acuerdo con la clasificación en vigor para el año solicitado (desde 1997 a 2015 inclusive códigos de Diagnósticos y Procedimientos en CIE9MC/ de 2016 en adelante códigos de diagnósticos y procedimientos en CIE10ES)

2.- LA RELACION DE CÓDIGOS CIE DEBERA ENVIARSE EN FORMATO EDITABLE bien en la propia solicitud (siempre que no sea una copia escaneada) o en fichero aparte mediante un listado de códigos separados por comas o en el caso de códigos sucesivos ENTRE A (código inicial) y B (código final).

PERIODO SOLICITADO: Años 2010 a 2023 (catorce ejercicios anuales).
BASE DE DATOS: RAE-CMBD. Modalidad: Hospitalización (TIPONT = 1). Ámbito: todo el territorio nacional (todas las CCAA). Régimen de financiación: todos los regímenes.
VARIABLES SOLICITADAS POR REGISTRO:
Identificación del centro (campo imprescindible):
— CEN_SAN: Se solicita EXPRESAMENTE sin anonimizar (código CNH/REGCESS de 6-9 dígitos) que permita el cruce directo con el Catálogo Nacional de Hospitales (CODCNH).
— CCAA del hospital. — Tipo Centro N4 (REGCESS). — SNS/No SNS.
— Grupo Hospital (tamaño en camas).
Case-mix (GRD) — variables esenciales para el objeto del estudio:
— GRD APR. — CDM APR. — Tipo GRD APR (Q/M).
— Nivel Severidad APR (1-4).
— Peso Español APR (peso individual del episodio).
Variables clínico-asistenciales del episodio:
— Estancia Días. — Tipo Alta. — Servicio. — Régimen Financiación.
— Tipo Ingreso. — Ingreso en UCI (S/N). — Días UCI.
Variables de procedimientos — imprescindibles para la construcción del indicador de intensidad asistencial:
— Número total de procedimientos codificados por episodio (variable escalar entera; no se solicitan los códigos individuales de procedimiento).
— Recuento de procedimientos agrupados por los siguientes capítulos de la clasificación CIE-9-MC (para episodios hasta 2015) y CIE-10-ES (desde 2016), solicitados como contadores numéricos por episodio sin identificación del código específico:

Grupo funcional	Capítulos CIE9-MC	Descripción
Diagnóstico por imagen	87–88	Radiodiagnóstico y otras exploraciones radiológicas
Diagnóstico clínico y laboratorio	89–91	Pruebas de función, análisis y procedimientos diagnósticos
Procedimientos cardiovasculares	35–39	Cirugía cardíaca, vascular y procedimientos hemodinámicos
Procedimientos digestivos y abdominales	42–54	Cirugía esofágica, gástrica, intestinal, hepática y pancreática
Procedimientos músculo-esqueléticos	76–84	Cirugía ósea, articular y de tejidos blandos
Procedimientos del sistema nervioso	01–05	Neurocirugía y procedimientos neurológicos
Procedimientos respiratorios	30–34	Cirugía torácica y procedimientos sobre vías respiratorias

Variables del paciente (sin identificación individual):
— Edad.
— Sexo.

NO SE SOLICITAN: CIP, Historia clínica, códigos individuales de diagnóstico, códigos individuales de procedimiento, CCAA de residencia del paciente, Riesgo de Mortalidad APR ni Grupo Clúster.

A.2.2. Finalidad y objetivos: (no más de 100 palabras)

El estudio analiza la eficiencia técnica de los hospitales del Sistema Nacional de Salud español (públicos y privados concertados) mediante técnicas de frontera de producción: análisis envolvente de datos (DEA) y fronteras estocásticas (SFA). Se requiere el índice de case-mix (peso medio GRD APR) por hospital y año como variable de output ajustado por complejidad de la casuística. Los datos del RAE-CMBD se cruzarán con el Catálogo Nacional de Hospitales (CNH) y el Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) para construir un panel hospitalario 2010-2023.

A.2.3. Elaboración y análisis

A partir de los registros individuales del RAE-CMBD se calcularán los siguientes indicadores agregados por centro sanitario (CEN_SAN / CODCNH) y año:

(i) Número de altas hospitalarias por hospital. **(ii)** Peso medio GRD APR por hospital (=índice de case-mix). **(iii)** Distribución de altas por CDM APR y tipo de GRD (Q/M). **(iv)** Estancia media ajustada por complejidad. **(v)** % altas por servicio y régimen de financiación. **(vi)** La variable de intensidad asistencial —uno de los dos "outputs" del modelo de frontera estocástica— se construirá como el número medio de procedimientos por alta, calculado a partir del recuento agregado de procedimientos por episodio y por capítulo funcional. Este indicador aproxima el volumen de servicios diagnóstico-terapéuticos efectivamente prestados por episodio, diferenciándolo del mero volumen de altas, en línea con la distinción teórica entre dimensión de cantidad e intensidad de la atención hospitalaria.

En ningún caso se utilizarán los códigos individuales de procedimiento: el análisis opera exclusivamente sobre los contadores agregados por hospital y año.

Una vez calculados los indicadores agregados, los registros individuales serán destruidos (art. 3 del Compromiso de Confidencialidad). Los indicadores se integrarán en un modelo de frontera en el que las variables de output (" " altas ajustadas por case-mix y variables de intensidad por case-mix) se combinarán con variables de "input" del SIAE (gasto corriente, personal) y del CNH (camas, equipamiento). El análisis estadístico se realizará con R (≥4.3).

A.2.4. Difusión de resultados

Los resultados se publicarán en artículos científicos en revistas indexadas en JCR/Scopus especializadas en economía de la salud (Health Economics, European J. of Health Economics, Health Policy) y en comunicaciones a congresos nacionales e internacionales (ECHE, iHEA, Encuentro de Economía de la Salud).

En todos los productos de difusión los resultados se presentarán en forma agregada, sin posibilidad de identificación directa ni indirecta de hospitales individuales (art. 4 del Compromiso). Se remitirá copia de todos los productos a la Subdirección General de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, citando expresamente el RAE-CMBD como fuente de datos.

B) COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

En relación con la solicitud de extracción de datos del RAE-CMBD efectuada a la Subdirección General de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, cuya finalidad, objetivos y alcance han sido especificados en la misma, me comprometo:

1.- A tratar toda la información bajo estrictas condiciones de confidencialidad.

2.- A no utilizar, y a no autorizar a cualquier persona física o jurídica para que use los datos cedidos que no sea exclusivamente para los fines del trabajo tal como están reflejados en la solicitud. Este compromiso será extensible a aquellos colaboradores designados por el peticionario, siendo responsabilidad de éste, el cumplimiento del mismo por parte de aquellos.

3.- A destruir el fichero o datos facilitados y todas las copias realizadas del mismo una vez transcurrido el plazo de tiempo para el que se precisan los datos.

4.- A publicar, en su caso, los resultados del estudio o trabajo para el que se piden los datos de forma que quede garantizada la protección de datos de carácter personal y que en ningún caso se puede identificar de manera directa o indirecta a las unidades estadísticas informantes individuales. El grado de desagregación de la información en cualquier producto de difusión que se obtenga a partir de los datos cedidos no debe permitir la identificación de unidades informantes concretas (Hospitales, Centros de Salud, o personas – según proceda en cada caso -).

5.- A enviar copia a la Subdirección General de Información Sanitaria de todos los informes de difusión pública que se produzcan a partir de los datos suministrados.

6.- A que en los productos de difusión obtenidos se haga referencia a la Subdirección General de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad como fuente de los datos y a hacer constar que el grado de exactitud o fiabilidad de la información derivada de la elaboración propia de los autores sea de la exclusiva responsabilidad de éstos.

7.- En cualquier caso, el tratamiento y difusión de la información atenderá a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal – y desde mayo de 2018 del Reglamento Europeo de Protección de Datos -, en la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como la Ley 12/1987 de Función Estadística Pública.

FECHA: Salamanca, 10 de marzo de 2026

FIRMA: